Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 04

Diverticulite e Pancreatite

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Não é referência bibliográfica

Não serve como material para recurso: a fonte original deve ser consultada.

Diverticulite e pancreatite

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Diverticulite: TC, Hinchey decide (antibiótico, drenagem ou cirurgia) e colonoscopia depois. Pancreatite: 2 de 3, Ringer moderado, dieta precoce, sem antibiótico profilático, CPRE só com colangite ou obstrução e, na biliar leve, colecistectomia antes da alta.

1. **Diverticulite:** TC com contraste; nada de colonoscopia na fase aguda.
2. **Não complicada:** ambulatorial se selecionada; antibiótico em selecionados.
3. **Abscesso grande:** drenagem percutânea. **Hinchey III/IV:** cirurgia.
4. **Hartmann** no instável; anastomose primária no estável selecionado.
5. **Pancreatite:** dor + lipase ≥ 3× + imagem (2 de 3).
6. **Grave** = falência de órgão por mais de 48 h (Atlanta).
7. **Ringer moderado**, dieta precoce, sem antibiótico profilático.
8. **Necrose infectada:** antibiótico; se estável, esperar ~4 semanas; step-up.

Coleções

	< 4 sem.	≥ 4 sem.
Edematosa	Líquida aguda	Pseudocisto
Necrosante	Necrótica aguda	Necrose encapsulada

Pegadinha

Lipase muito alta não é gravidade. TC na admissão subestima a necrose.

Checklist antes da prova

- ☐ Sei Hinchey e a conduta de cada um
- ☐ Sei quando dispensar o antibiótico
- ☐ Sei Hartmann × anastomose primária
- ☐ Faço o diagnóstico 2 de 3
- ☐ Sei Atlanta e BISAP
- ☐ Sei hidratar, alimentar e quando fazer CPRE
- ☐ Sei as coleções e o step-up